

Press Releases

Home / News



中大與北大亞洲首項臨床研究發現 數碼化失眠介入程式可降低青年失眠患者抑鬱症發病率逾四成

2025年2月20日

香港中文大學（中大）醫學院與北京大學（北大）第六醫院聯合開展的亞洲首項數碼化失眠認知行為治療（簡稱數碼化CBT-I入程式）的臨床研究顯示，此程式除了可顯著改善青年患者的失眠及抑鬱症狀，更可將抑鬱症發病率大幅降低四成以上，療效持久且反應良好。此突破性發現意味著數碼化CBT-I有望為中國、亞洲以至全球青年提供一種有效、更普及和自助化的嶄新治療，為青年數碼精神健康發展開創全新局面。此項研究已刊載於國際頂尖醫學期刊《PLoS Medicine》。

抑鬱症是全球12億青年人口^[1]中最常見的精神疾病之一，醫療資源供不應求；加上求助率極低，醫生、患者與家屬均承受沉重負擔。醫學界已發現失眠與抑鬱密切的因果關係，且為抑鬱症發病的獨立危險因素，惟關於改善青年失眠能否預防抑鬱症的臨床實證不足，特別是在使用數碼化治療手段方面，因而限制了醫生及年輕患者的選擇。

The banner features logos of CUHK, CUHK Faculty of Medicine, Peking University, and Peking University Sixth Hospital. The main text in Chinese and English states: '中大與北大亞洲首項臨床研究發現 數碼化失眠介入程式可降低青年失眠患者抑鬱症發病率逾四成' and 'Asia's first clinical research by CUHK and PKU finds that app-based insomnia intervention can reduce the incidence rate of major depressive disorder in youth with insomnia by more than 40%'. Below the text is a photo of three researchers at a press conference: Professor Lin Li (left), Professor Yun Kwok WING (middle), and Dr. Chen Siqing (right).

中大和北大合作的研究顯示了數碼精神健康發展對解決龐大臨床需求的重要性，並表明預防及早期治療是減輕青年抑鬱症患病負擔的關鍵。

圖為是次研究團隊成員（左起）中國科學院院士兼北京大學第六醫院院長**陸林教授**、卓敏精神科學教授、中大醫學院精神科學系系主任兼李朝江家族睡眠檢查室主任**榮潤國教授**，及是次研究第一作者、中大醫學院精神科學系博士後研究員**陳斯婧博士**。

失眠既是抑鬱症的誘因，亦是其常見症狀。抑鬱症患者除了長期情緒低落外，普遍會反覆出現失眠症狀，使患者不但身心健康及社交能力受嚴重影響，甚至產生自殺念頭。

青年處於成長的過渡期，屬易受精神疾病影響的人群。有研究顯示四分之三的精神疾病個案於24歲前發病。根據世衛資料^[2]，全球15至19歲青年中有3.5%會出現抑鬱症。調查顯示中國內地約有2%的青年患有抑鬱症^[3]，而另有研究顯示香港的比例約為3.9%-5.2%^[4]。因此，處理青年人失眠問題有望及早降低他們罹患抑鬱症的風險。

中國科學院院士兼北京大學第六醫院院長**陸林教授**表示：「CBT-I是有效治療慢性失眠的一線療法。醫學界的難題，在於亞洲尚未研究此方案對預防青年抑鬱的療效及以數碼方式替代面診治療的作用。調查研究顯示，中國內地及香港地區青年失眠患者求助率僅一成，這一數據突顯高危年輕人群對傳統治療方案的接受度極低，引致罹患抑鬱症的風險大增。」

數碼化CBT-I介入程式顯著改善青年失眠及抑鬱症狀 抑鬱症發病率降低逾四成



▲ 是次研究以臨床實證為本，治療效果令人滿意且療效持久，證明相較於面診治療，數碼自助化治療方式更易於被稱為『網絡原住民』的青年接受。

是次研究的參加者包括708名年齡介乎15至25歲、來自中國內地及香港的青年，當中57%為女性。所有參加者均患有失眠症，並伴有亞臨床抑鬱症狀^[5]。研究團隊將參加者平均及隨機地分為兩組：對照組，前者通過手機接受為期六週的數碼化CBT-I介入治療，後者則接受手機健康教育^[6]。兩組在經過多項臨床及追蹤後^[7]，接受六個月及十二個月的跟進。

是次研究結果證明，數碼化CBT-I介入程式在失眠症及抑鬱症方面均展現「一舉兩得」的療效：

- **改善症狀：**晝夜作息及日間疲勞情況有所改善；自我評估抑鬱症狀顯著減少。>
- **緩解病情：**介入一年後，失眠緩解率接近60%，抑鬱發病率對照組相比大幅下跌42%，介入組的抑鬱症發病率僅有10%，而對照組則為18%。
- **反應積極：**90%的參加者完成至少一次跟進評估，其完成整個療程的比率為84%，且無不良事件發生^[8]。

是次研究第一作者、中大醫學院精神科學系博士後研究員**陳斯婧博士**表示：「治療效果令人滿意，證明數碼化CBT-I介入程式可有效預防及治療失眠及抑鬱症；極高的完成率更反映全自主的治療方式能有效鼓勵青年患者積極了解自己的睡眠及身心健康並處理精神困擾。此重大發現揭示，數碼自助化治療方式更易於被稱為『網絡原住民』的青年接受，這突破了青年精神健康治療的瓶頸。」

卓敏精神科學教授、中大醫學院精神科學系系主任兼李朝江家族睡眠檢查室主任**榮潤國教授**補充：「這次研究顯示了數碼化治療對解決龐大臨床需求的重要性，並表明預防及早期治療是減輕青年抑鬱症患病負擔的關鍵。展望未來，醫學界應探索如何在基層醫療等方面將數碼化治療失眠方案與臨床實踐相結合，並研究如何改良此嶄新治療方案，促進個人化預防和早期治療在社區中的發展及應用。」

^[1] 聯合國2024年的資料顯示，青年人口的年齡介乎15至24歲。

^[2] 根據世衛與世界銀行進行的全球疾病負擔（Global Burden of Disease）研究。

^[3] 根據國家衛生健康委員會2024年的資料。

^[4] 根據2023年香港中文大學精神健康研究（LET'S WORK HEART 界心機）。

^[5] 抑鬱症狀持續出現至少兩週並伴有日常功能受損者一般會被診斷為抑鬱障礙患者。

^[6] 手機健康教育涵蓋認識睡眠、營養學知識、認識腦部健康等內容。

^[7] 介入後的跟進評估長達一年，評估包括國際神經精神科簡式訪談問卷（MINI-International Neuropsychiatric Interview）、ICD-10失眠診斷標準、失眠嚴重指數量尺（Insomnia Severity Index, ISI）、病人健康問卷-9（Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9）等。

^[8] 用藥物或其他療法治療時發生的意外醫療問題。

更多新聞稿



中大醫學院研發的手機
程式有效評估抑鬱症

研究



中大推出全港首個大型
睡眠健康社區推廣計劃
「賽馬會樂眠無憂計...

健康推廣計劃



中大證實抑鬱症與快速
眼動睡眠期行為障礙共
病患者的直系親屬更...

研究

◀ 上一個

香港中文大學生命倫理學中心
慶祝成立十周年 匯聚全球專家
攜手應對醫學及科技的生命倫
理挑戰



中大研究指
加濕疹等過

我們的專家

醫學院的許多專家都可以接受媒體採訪。
請[點擊此處](#)查看專家名單或聯繫我們。

更多

